

Coupes axiales de TDM abdomino-pelvienne avec injection au temps portal (2 patients distincts)

Intestin
grêle dilaté
(> 25 mm)

Jonction =
Bride

Intestin
grêle plat

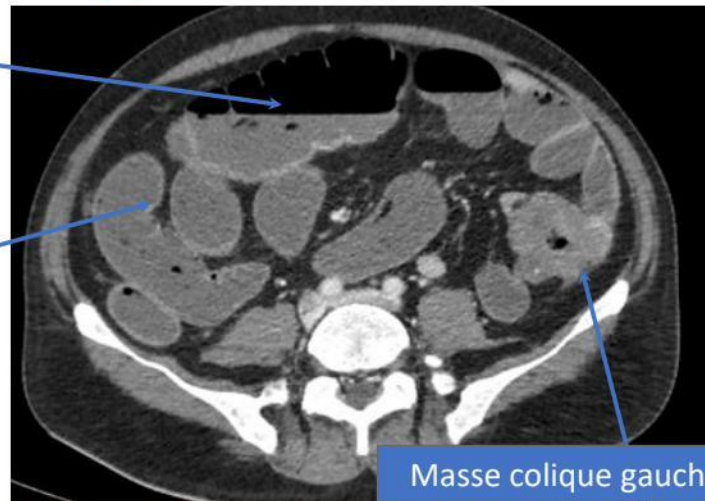


Occlusion de l'intestin grêle secondaire à une bride

Colon dilaté
(> 60 mm)

Intestin
grêle dilaté
(> 25 mm)

Colon plat



Masse colique gauche

Occlusion colique secondaire à un cancer colique gauche

AMONT

Dilatation du
tube digestif

OBSTACLE



AVAL

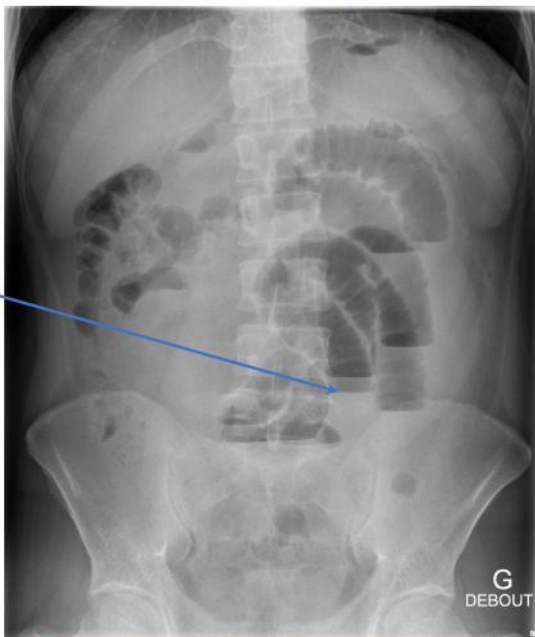
Aspect plat du
tube digestif

Occlusion de l'intestin grêle : dilatation de l'IG en amont, aspect plat du côlon et de l'IG en aval

Occlusion colique : dilatation du côlon +/- de l'IG (IG dilaté si valvule iléo-caecale non continente)

Radiographie de l'Abdomen Sans Préparation (ASP)

Cliché debout



Niveau hydro-aérique au sein des anses grêles

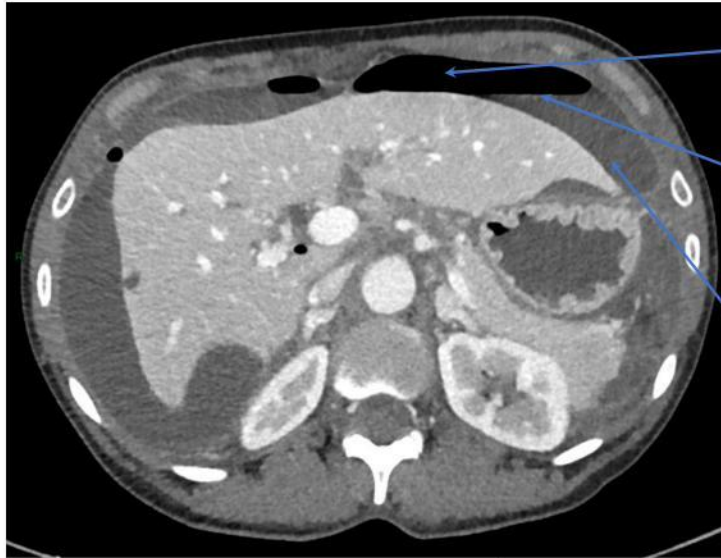


Le cliché d'ASP ne doit plus être demandé dans le cadre d'une occlusion digestive (HAS 2009)

Occlusion de l'intestin grêle

B. Connaître les 3 signes scanographiques principaux d'une péritonite

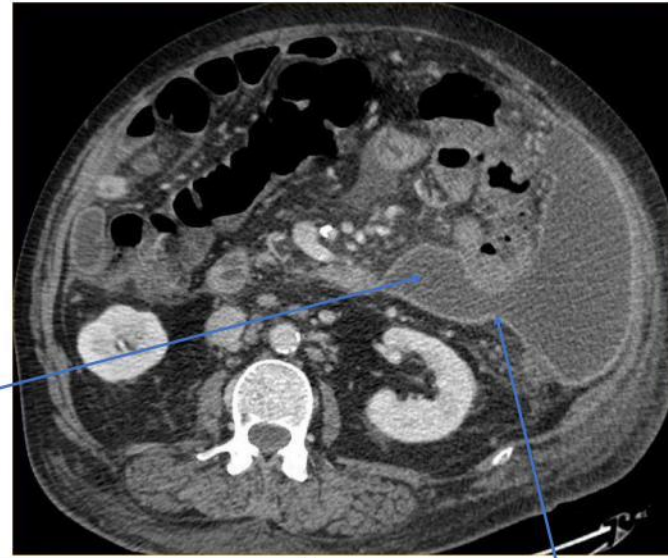
TDM abdomino-pelvienne, coupe axiale, avec injection au temps portal (2 patients distincts)



Pneumopéritoine = air
dans la cavité
péritonéale

Niveau hydro-aérique

Épanchement liquidien
péritonéal =
épanchement
hypodense homogène



Épaississement et
rehaussement des
feuillets péritonéaux

Péritonite aiguë

3 signes de péritonite

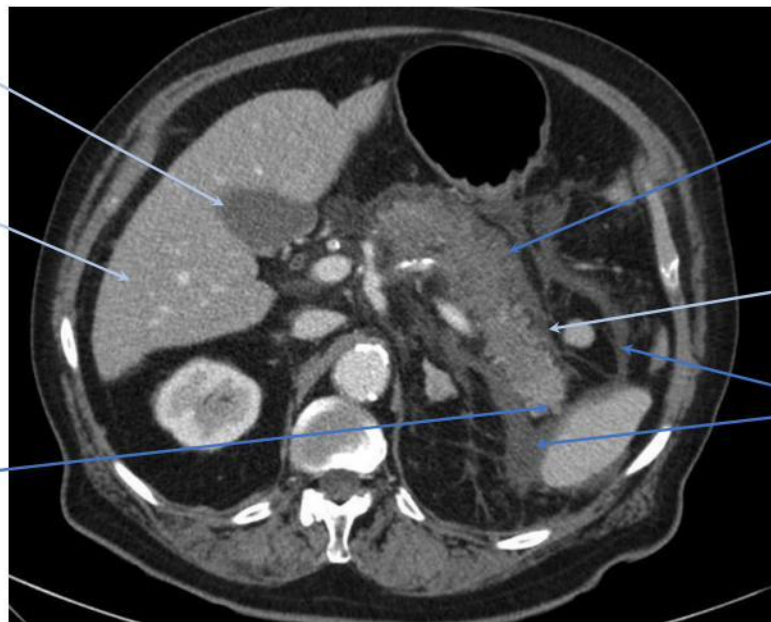
1. Pneumopéritoine
2. Épanchement liquidien péritonéal
3. Épaississement et rehaussement des feuillets péritonéaux

B. Exemple TDM d'une pancréatite aiguë nécrosante

TDM abdomino-pelvienne, coupe axiale, avec injection au temps portal

Vésicule
biliaire

Foie

Pancréas non
nécrosé (= se
rehausse)Parenchyme pancréatique non
rehaussé = Nécrose pancréatique

Queue du pancréas

Collections liquidiennes

Pancréatite aiguë nécrosante

Score CTSI 10
Nécrose du parenchyme pancréatique > 50% (6 pts)
Au moins 2 collections liquidiennes (4 pts)